

약제 영양급여의 적정성 평가결과

cabotegarvir sodium micronized 30mg,

cabotegravir 600mg/3mL,

rilpivirine micronized 900mg/3mL

(보카브리아정30밀리그램(카보테그라비르나트륨),
보카브리아주(카보테그라비르), 레캄비스주사(릴피비린),
(주)글락소스미스클라인, (주)한국얀센)

□ 제형, 성분·함량:

- (보카브리아정) 1정 중 cabotegravir sodium micronized 30mg
- (보카브리아주) 1병 중 cabotegravir 600mg/3mL
- (레캄비스주사) 1병 중 rilpivirine micronized 900mg/3mL

□ 효능·효과

- (보카브리아정) 바이러스학적으로 억제되어 있고 (HIV-1 RNA<50 copies/mL), 치료 실패 이력이 없으며 카보테그라비르 또는 릴피비린에 알려진 또는 의심되는 내성이 없는 성인 환자에서 HIV-1 감염의 단기 치료를 위한 릴피비린 정제와의 병용요법
 - 장시간 작용형 카보테그라비르 및 릴피비린 주사 투여 전에 카보테그라비르의 내약성 평가를 위한 경구 도입요법
 - 카보테그라비르와 릴피비린 주사요법을 일시적으로 대체하려는 환자에서의 경구요법
- (보카브리아주) 바이러스학적으로 억제되어 있고 (HIV-1 RNA<50 copies/mL), 치료 실패 이력이 없으며 카보테그라비르 또는 릴피비린에 알려진 또는 의심되는 내성이 없는 성인 환자에서 HIV-1 감염 치료를 위한 릴피비린 주사와의 병용요법
- (레캄비스주사) 바이러스학적으로 억제되어 있고 (HIV-1 RNA<50 copies/mL), 치료 실패 이력이 없으며 릴피비린 또는 카보테그라비르에 알려진 또는 의심되는 내성이 없는 성인 환자에서 HIV-1 감염 치료를 위한 카보테그라비르 주사와의 병용요법

☐ 약제급여평가위원회 심의일

2024년 제12차 약제급여평가위원회: 2024년 12월 5일

- 약제급여기준소위원회 심의일: 2024년 8월 18일

※ 약제급여평가위원회 평가결과 중 해당 제약회사의 영업상 비밀에 해당하는 내용(신청자의견, 신청가격 및 이와 관련된 투약비용, 재정영향 금액 등)은 공개대상에서 제외하였습니다.

가. 평가 결과

- 급여의 적정성이 있음
- 신청품은 “바이러스학적으로 억제되어 있고 (HIV-1 RNA < 50 copies/mL), 치료 실패 이력이 없으며 카보테그라비르 또는 릴피비린에 알려진 또는 의심되는 내성이 없는 성인 환자에서 HIV-1 감염 치료를 위한 병용요법”에 허가받은 약제로, HIV-1 환자의 바이러스학적 미반응 환자 비율 등에서 대체약제 대비 비열등성이 인정되며, 소요비용이 대체약제 이하로 비용 효과적이므로 급여의 적정성이 있으며, 약가협상생략기준금액(), 보카브리아정 원/정, 보카브리아주 원/병, 레캄비스주사 원/병) 이하를 수용할 경우 상한금액 협상절차를 생략함.

나. 평가 내용

- 진료상 필수 여부
- 신청품은 “바이러스학적으로 억제되어 있고 (HIV-1 RNA < 50 copies/mL), 치료 실패 이력이 없으며 카보테그라비르 또는 릴피비린에 알려진 또는 의심되는 내성이 없는 성인 환자에서 HIV-1 감염 치료를 위한 병용요법”에 허가 받은 약제로, 현재 abacavir/lamivudine/dolutegravir 등이 등재되어 있으므로 대체가능성 등을 고려 시, 약제의 요양급여대상여부 등의 평가기준 및 절차 등에 관한 규정 제6조(진료상 반드시 필요하다고 판단되는 약제)에 해당한다고 보기 어려움.
- 임상적 유용성
- 신청품은 “바이러스학적으로 억제되어 있고 (HIV-1 RNA < 50 copies/mL), 치료 실패 이력이 없으며 카보테그라비르 또는 릴피비린에 알려진 또는 의심되는 내성이 없는 성인 환자에서 HIV-1 감염 치료를 위한 병용요법”에 사용하는 약제로, 보카브리아주(카보테그라비르)와 레캄비스주사(릴피비린)는 병용요법으로 사용하며, 보카브리아정(카보테그라비르나트륨)은 릴피비린 정제¹⁾와 병용요법으로 주사 투여 전 내약성 평가를 위한 경구 도입요법 및 주사요법을 일시적으로 대체하는 경구요법에 사용함.
 - 카보테그라비르는 통합효소 억제제(Integrase strand transfer inhibitor, INSTI)로, HIV 증식과정 중 HIV DNA가 표적세포의 DNA로 끼어들어가는 인테그레이션 단계에서 촉매 작용을 하는 효소인 인테그레이스의 활성 부위에 결합하여 나선 이동(strand transfer)을 차단함으로써 HIV 인테그레이션 단계를 억제함.
 - 릴피비린은 비뉴클레오사이드계 역전사효소 억제제(Non-nucleoside reverse transcriptase inhibitor, NNRTI)로, 역전사효소에 결합하여 효소 단백질 구조를 변형시킴으로써 약효를 나타내며, HIV-1에만 선택적으로 작용하여 세포의 DNA 중합효소에 거의 영향을 미치지 않아 부작용이 적음.

- 신청품은 교과서²⁾³⁾⁴⁾⁵⁾ 및 임상진료지침⁶⁾⁷⁾⁸⁾에서 바이러스학적으로 억제된 환자에서 사용할 수 있는 장기 지속형 주사 병용 요법으로 소개되고 있음.
 - HIV 치료에서 최초로 허가된 주사요법으로 경구 항레트로바이러스요법 대비 비열등성을 입증하였으며, 내약성을 파악하기 위해 약 1개월간 경구 도입요법을 고려할 수 있다고 언급됨.
- [FLAIR, Q4W, 비열등성시험]⁹⁾ 항레트로바이러스치료(ART)를 받은 적 없는 18세 이상 HIV-1 감염인(n=556)을 대상으로 유도기간 동안 DTG/ABC/3TC(트리맥정)¹⁰⁾ 투여 후 바이러스가 억제된 환자에서, 경구투여 지속 대비 cabotegravir + rilpivirine 장기지속형 주사제(CAB+RPV LA) 4주 요법의 효능과 안전성을 평가한 다기관, 공개, 무작위배정 3상 임상시험 결과¹¹⁾,
 - 1차 평가지표인 유지기간 48주차 바이러스학적 미반응(HIV-1 RNA ≥ 50 copies/mL) 환자 비율은 신청품군에서 2.1%(6/283명), 대조군 2.5%(7/283명)로 비열등성을 입증함 (adjusted difference -0.4%p; 95% CI -2.8~2.1, 비열등성 마진 95% CI 상한 6%p 이내).
 - ✓ 96주차에는 신청품군 3%(9/283명), 대조군 3%(9/283명)로 비열등성을 입증함 (adjusted difference 0.0%p; 95% CI -2.9~2.9, 비열등성 마진 95% CI 상한 6%p 이내)¹²⁾.
 - 2차 평가지표인 48주차 바이러스학적 억제(HIV-1 RNA < 50 copies/mL) 환자비율은 신청품군 96.6%, 대조군 93.3%로 비열등성을 입증함(adjusted difference 0.4%p; 95% CI -3.7~4.5, 비열등성 마진 95% CI 하한 -10%p 이내).
 - ✓ 96주차에는 신청품군 87%, 대조군 89%로 비열등성을 입증함(adjusted difference -2.8%p; 95% CI -8.2~2.5, 비열등성 마진 95% CI 하한 -10%p 이내)¹³⁾.
 - 124주 연장연구¹⁴⁾에서, 처음부터 신청품군으로 무작위배정된 환자군(n=283)과 대조군이었지만 연장기간에 신청품군으로 처치전환한 환자 중 DTI(Direct-to-injection)군(n=111) 및 OLI(Oral lead-in)군(n=121)의 결과를 제시하였으며, 지속적인 치료 반응을 보임.

구분	평가지표	1차 평가지표		2차 평가지표		
		바이러스학적 미반응 환자 비율		바이러스학적 억제 환자 비율		
		신청품군	대조군	신청품군	대조군	
48주	환자 비율	2%	1%	94%	93%	
	Adjusted difference(95% CI)	0.8%p (-0.6~2.2)		0.8%p (-2.1~3.7)		
96주	환자 비율	2%	1%	91%	90%	
	Adjusted difference(95% CI)	1.0%p (-0.6~2.5)		0.8%p (-2.8~4.3)		
비열등성 마진		95% CI 상한 6%p		95% CI 하한 -10%p		
124주		신청품군	DTI군	OLI군	신청품군	DTI군
	환자 비율	5%	1%	1%	80%	99%
	(95% CI)	(2-8)	(0-3)	(0-2)	(76-85)	(97-100)

- 안전성 평가결과, 신청품군에서 주사 부위 반응을 제외하고 가장 흔한 이상반응은 비인두염, 두통, 상기도 감염, 설사였음. 심각한 이상반응은 신청품군에서 6%(18/283명), 대조군에서 4%(12/283명)로 나타남.
- ✓ 신청품군의 86%가 적어도 1번 이상의 주사 부위 반응을 경험하였으며, 가장 흔한

반응은 통증(82%)이었고 대부분 경증(86%) 또는 중등증(13%)이었음. 첫 투여 시 가장 많이 보고되었으며(71%), 48주차에 20%로 감소함. 주사 부위 반응이 나타난 기간의 중앙값은 3일이었으며 88%가 7일 이내에 증상이 사라짐.

- [ATLAS, Q4W, 비열등성시험]¹⁵⁾ 바이러스학적 실패가 없고 최소 6개월간 경구 3제 요법(2NRTI+3rd agent)¹⁶⁾을 유지 중인 성인 HIV-1 환자¹⁷⁾(n=616)를 대상으로 기존 경구 치료제 대비 CAB+RPV LA 4주 요법의 효능과 안전성을 효능과 안전성을 평가한 다기관, 공개, 무작위배정 3상 임상시험 결과¹⁸⁾,

- 1차 평가지표인 유지기간 48주차 바이러스학적 미반응(HIV-1 RNA $\geq$ 50 copies/mL) 환자 비율은 신청품군에서 1.6%(5/308명), 대조군 1.0%(3/308명)로 비열등성을 입증함 (adjusted difference 0.6%p; 95% CI -1.2~2.5, 비열등성 마진 95% CI 상한 6%p 이내).
- ✓ 2차 평가지표인 48주차 바이러스학적 억제(HIV-1 RNA<50 copies/mL) 환자비율은 신청품군 92.5%, 대조군 95.5%로 비열등성을 입증함(adjusted difference -3.0%p; 95% CI -6.7~0.7, 비열등성 마진 95% CI 하한 -10%p 이내).
- 안전성 평가결과, 신청품군에서 주사 부위 반응을 제외하고 가장 흔한 이상반응은 비인두염, 상기도 감염, 두통, 설사였음. 심각한 이상반응은 신청품군에서 4%(13/308명), 대조군에서 5%(14/308명)로 나타남.
- ✓ 신청품군의 81%가 주사 부위 반응을 경험하였으며, 가장 흔한 반응은 통증(92%) 이었고 대부분(99%) 경증 또는 중등증이었음. 치명적인(Grade 4~5) 이상반응은 보고 되지 않았고 대부분 7일 내에 증상이 사라짐.

- [SOLAR, Q8W, 비열등성시험]¹⁹⁾ 최소 6개월간 바이러스 억제 상태의 성인 HIV-1 환자로 BIC/FTC/TAF(빅타비정)²⁰⁾을 중단 없이 투여 받고 있는 환자²¹⁾(n=670)를 대상으로, CAB+RPV LA 8주 요법 전환(n=447) 또는 경구 투여 지속군(n=223)으로 2:1 무작위 배정한 다기관, 공개, 3상 임상시험 결과,

- 신청품군은 경구 도입요법을 시행하는 OLI(Oral lead-in)군(n=173)과 바로 주사요법을 시작하는 SWI(Start with injection)군(n=274)으로 나뉘며, SWI군은 11개월, OLI군 및 대조군은 12개월차에 평가함²²⁾.
- 1차 평가지표인 유지기간 48주차 바이러스학적 미반응(HIV-1 RNA $\geq$ 50 copies/mL) 환자 비율은 신청품군에서 1%(5/447명), 대조군 <1%(1/223명)로 비열등성을 입증함 (adjusted difference 0.7%p; 95% CI -0.37~2.0, 비열등성 마진 95% CI 상한 4%p 이내).
- 2차 평가지표인 48주차 바이러스학적 억제(HIV-1 RNA<50 copies/mL) 환자비율은 신청품군 90%, 대조군 93%로 비열등성을 입증함(adjusted difference -2.7%p; 95% CI -7.0~1.7, 비열등성 마진 95% CI 하한 -12%p 이내).
- 안전성 평가결과, 주사 부위 반응을 제외하고 가장 흔한 이상반응은 COVID-19 감염 이었으며, 신청품군에서 약물 관련 이상반응 중 가장 흔한 이상반응은 발열, 두통, 피로, 설사였음.

- ✓ 신청품군의 62%에서 주사 부위 반응이 보고되었으며, SWI군과 OLI군의 주사 부위 반응 프로파일은 유사했으며, 98%가 경증 또는 중등증이었음. 주사 부위 반응이 나타난 기간의 중앙값은 3일이었으며, 보고율은 시간이 지남에 따라 감소함.

- [ATLAS-2M, Q8W vs. Q4W, 비열등성시험]²³⁾ 바이러스학적 실패가 없고 최소 6개월간 경구 3제 요법(2NRTI+3rd agent)²⁴⁾을 유지 중인 성인 HIV-1 환자 또는 ATLAS 시험에 참여했던 환자²⁵⁾(n=1,045)를 대상으로 CAB+RPV LA 8주 요법(n=522)과 4주 요법(n=523)의 효능과 안전성을 평가한 다기관, 공개, 무작위배정 3상 임상시험 결과²⁶⁾,

- 1차 평가지표인 바이러스학적 미반응 환자 비율 및 2차 평가지표인 바이러스학적 억제 환자 비율을 48주, 96주²⁷⁾, 152주²⁸⁾에 평가하였으며, 비열등성을 입증함.

구분	평가지표	1차 평가지표		2차 평가지표	
		바이러스학적 미반응 환자 비율		바이러스학적 억제 환자 비율	
		4주 요법	8주 요법	4주 요법	8주 요법
48주	환자 비율	2%	1%	94%	93%
	Adjusted difference(95% CI)	0.8%p (- 0.6~2.2)		0.8%p (-2.1~3.7)	
96주	환자 비율	2%	1%	91%	90%
	Adjusted difference(95% CI)	1.0%p (- 0.6~2.5)		0.8%p (-2.8~4.3)	
152주	환자 비율	2.7%	1%	87.4%	85.9%
	Adjusted difference(95% CI)	1.7%p (0.1~3.3)		1.5%p (- 2.6~5.6)	
비열등성 마진		95% CI 상한 6%p		95% CI 하한 -10%p	

- 안전성 평가결과, 이상반응 보고 중 91%는 경증 또는 중등도였으며, 2%가 이상반응으로 인해 시험을 중단함. 주사 부위 반응을 제외하고 두 군에서 가장 흔한 이상반응은 비인두염, 상기도감염, 발열, 두통 등이었으며 심각한 이상반응은 8주 요법군의 5%, 4주 요법군의 4%에서 보고됨.

- ✓ 주사 부위 반응은 가장 흔한 이상반응이었으며 8주 요법군의 76%, 4주 요법군의 75%에서 나타남. 가장 흔한 반응은 통증(8주 요법군 95%, 4주 요법군 93%)이었고, 대부분(전체 주사 부위 반응의 98%) 경증 또는 중등증이었으며 두 군 모두 86%가 7일 이내(중앙값 3일)에 증상이 사라짐.

- 관련 학회²⁹⁾에 따르면, 신청품은 주요 임상시험에서 기존 경구 치료제 대비 바이러스 억제 효과의 비열등성 및 내약성을 입증하였으며, 투약 횟수를 연간 6회로 줄여 약제미복용으로 인한 내성 발생의 위험 및 감염인의 심리사회적 어려움을 개선하여 삶의 질 향상에 기여할 수 있다는 의견임.

○ 비용 효과성

- 신청품의 급여기준(안), 임상연구문헌, 제외국 평가 및 학회의견 등을 고려하여 현행 경구 항레트로바이러스요법을 대체약제로 선정함.
 - STR: ABC/3TC/DTG, TAF/FTC/EVG/c, TAF/FTC/BIC, TDF/3TC/DOR, 3TC/DTG
 - MTR: 3제 요법(2NRTI + 3rd agent) 및 2제 요법
 - ✓ 2NRTI: TDF/FTC, TAF/FTC, ABC/3TC
 - ✓ 3rd agent: INSTI(DTG, RAL), NNRTI(DOR, RPV), PI(ATV/c, DRV/c, LPV/r)
 - ✓ 2제 요법: DTG+3TC, DTG+RPV, 3TC+DRV/c, RAL+DRV/c, DTG+DRV/c, 3TC+ATV/c, 3TC+LPV/r
- 신청품 병용요법의 1일 소요비용(■■■■원)은 대체요법 가중 1일 소요비용(■■■■원)과 동일함.
 - 대체약제 가중평균가를 반영한 신청약제의 단위비용은 보카브리아정 ■■■■원/정, 보카브리아주 ■■■■원/병, 레캄비스주사 ■■■■원/병이며, 약가협상생략기준금액³⁰⁾은 보카브리아정 ■■■■원/정, 보카브리아주 ■■■■원/병, 레캄비스주사 ■■■■원/병임.

○ 재정 영향³¹⁾

- 제약사 제출 예상사용량³²⁾을 기준으로 신청품 병용요법의 도입 후 절대재정소요금액³³⁾은 1차년도 약 ■■■■원, 3차년도 약 ■■■■원이고, 대체약제의 대체로 인한 재정 증분은 없음³⁴⁾.

※ 신청품의 대상 환자수 및 시장 점유율 등에 따라 재정영향은 변동될 수 있음.

○ 제외국 약가집 수재 현황

- 신청품은 A8 국가 중 8개국(미국, 영국, 독일, 프랑스, 이탈리아, 스위스, 일본, 캐나다) 약가집에 수재되어 있음.

References

- 1) 에듀란트정25밀리그램(릴피비린)이 현재 급여되고 있음.
- 2) Goodman & Gilman's: The Pharmacological Basis of Therapeutics, 14e, 2022
- 3) Harrison's Principles of Internal Medicine, 21th, 2022
- 4) Current Medical Diagnosis & Treatment, 2025
- 5) DiPiro's Pharmacotherapy: A Pathophysiologic Approach, 12e, 2023
- 6) Panel on Antiretroviral Guidelines for Adults and Adolescents. Guidelines for the Use of Antiretroviral Agents in Adults and Adolescents With HIV. Department of Health and Human Services. Updated 2024.9.12.
- 7) European AIDS Clinical Society (EACS). EACS Guideline, version 12.0, October 2023
- 8) British HIV Association(BHIVA). BHIVA guidelines on antiretroviral treatment for adults living with HIV-1 2022 (2023 interim update)
- 9) Orkin C et al. Long-Acting Cabotegravir and Rilpivirine after Oral Induction for HIV-1 Infection. N Engl J Med. 2020 Mar 19;382(12):1124-1135.
- 10) Dolutegravir/abacavir/lamivudin 50/600/300mg
- 11) 항레트로바이러스치료(ART)를 받은 적 없는 18세 이상 HIV-1 감염인(HIV-1 RNA $\geq 1,000$ copies/mL)을 대상으로, 유도기간 동안 DTG/ABC/3TC 50/600/300mg 일일 경구 투여한 후 (HLA-B*5701 양성 환자는 ABC를 제외한 2NRTI와 DTG 투여), 유지기간 시작 4주 전 HIV-RNA < 50 copies/mL인 피험자에 대해 경구 투여 지속(n=283)과 CAB+RPV Q4W 전환(n=283)으로 1:1 무작위배정함. 유지기간 첫 4주 동안 시험군 환자들은 CAB 30mg+RPV 25mg 일일 경구 투여하여 내약성을 평가함.
- 12) Orkin C et al. Long-acting cabotegravir plus rilpivirine for treatment in adults with HIV-1 infection: 96-week results of the randomised, open-label, phase 3 FLAIR study. Lancet HIV. 2021 Apr;8(4):e185-e196.
- 13) Orkin C et al. Long-acting cabotegravir plus rilpivirine for treatment in adults with HIV-1 infection: 96-week results of the randomised, open-label, phase 3 FLAIR study. Lancet HIV. 2021 Apr;8(4):e185-e196.
- 14) Orkin C et al. Initiation of long-acting cabotegravir plus rilpivirine as direct-to-injection or with an oral lead-in in adults with HIV-1 infection: week 124 results of the open-label phase 3 FLAIR study. Lancet HIV. 2021 Nov;8(11):e668-e678.
- 15) Swindells S et al. Long-Acting Cabotegravir and Rilpivirine for Maintenance of HIV-1 Suppression. N Engl J Med. 2020 Mar 19;382(12):1112-1123.
- 16) 2NRTI+(INSTI 또는 NNRTI 또는 PI 또는 unboosted atazanavir)으로 정의함.
일반화를 극대화하기 위해 DTG/ABC/3TC(트리멕정) 투여환자는 대부분 FLAIR 임상시험에 참여하였기 때문에 제외함.
- 17) screening 전 6개월, 12개월 이내로 혈장 HIV-1 RNA < 50 copies/mL의 기록이 있어야 함.
- 18) 기존 ART의 3rd agent 종류(PI, INSTI, NNRTI)와 선천적 성별을 기준으로 무작위 층화하였음. 52주째에 시험군과 대조군에서 자격이 있는 피험자들에게 CAB+RPV LA 치료법을 4주 또는 8주마다 받을 수 있는 ATLAS-2M 무작위 임상시험 참여를 권유하였음.
- 19) Ramgopal MN et al. Efficacy, safety, and tolerability of switching to long-acting cabotegravir plus rilpivirine versus continuing fixed-dose bictegravir, emtricitabine, and tenofovir alafenamide in virologically suppressed adults with HIV, 12-month results (SOLAR): a randomised, open-label, phase 3b, non-inferiority trial. Lancet HIV. 2023 Sep;10(9):e566-e577.
- 20) Bictegravir/emtricitabine/tenofovir alafenamide 50/200/25mg
- 21) - 스크리닝 전 최소 6개월 동안 HIV-1 바이러스가 검출 불가능한 상태(< 50 copies/mL)가 유지된 환

- BIC/FTC/TAF가 첫 번째 또는 두 번째 요법이어야 하며, 두 번째 요법인 경우 첫 번째 치료법은 INSTI 기반 요법이었어야 함.
- 22) OLI 또는 SWI의 선택은 참여자와 조사자의 상담을 통해 참여자가 결정하며, OLI를 선택한 참여자는 경구 CAB+RPV를 한 달 동안 투여하고 마지막 경구 투여 1개월 뒤 안전성 평가를 진행하고 장기 지속형 주사를 투여함. 두 번째 주사 투여는 2개월 차 방문 시에 이루어지며, 이후 매 2개월마다 투여함. SWI 요법을 선택한 참여자의 경우 1일차에 장기지속형 주사를 투여하며, 두 번째 주사는 1개월차에, 이후 매 2개월마다 투여함.
- 23) Overton ET et al. Long-acting cabotegravir and rilpivirine dosed every 2 months in adults with HIV-1 infection (ATLAS-2M), 48-week results: a randomised, multicentre, open-label, phase 3b, non-inferiority study. Lancet. 2021 Dec 19;396(10267):1994-2005.
- 24) 2NRTI+(INSTI 또는 NNRTI 또는 PI 또는 unboosted atazanavir)으로 정의함.
일반화를 극대화하기 위해 DTG/ABC/3TC(트리멕정) 투여환자는 대부분 FLAIR 임상시험에 참여하였기 때문에 제외함.
- 25) 스크리닝 시 혈장 HIV-1 RNA<50 copies/mL인 성인 HIV-1 환자로,
 - 새로 enroll된 참여자: oral ART 치료를 최소 6개월 전부터 유지 중인 환자로 이전에 바이러스학적 실패가 없고(≥ 400 copies/mL), 12개월간 적어도 2회 HIV-1 RNA<50 copies/mL 기록이 있어야 함.
 - ATLAS study 참여자: 최소 52주간 CAB+RPV LA 4주 주기 투여법 또는 ART 치료를 지속적으로 받은 환자
- 26) 피험자를 1:1 비율로 4주 요법군과 8주 요법군에 무작위배정하였으며, 과거 CAB+RPV 노출 기간을 '0, 1~24주, 24주 초과' 3종류로 계층화하여 무작위배정함.
- 27) Jaeger H et al. Long-acting cabotegravir and rilpivirine dosed every 2 months in adults with HIV-1 infection (ATLAS-2M), 96-week results: a randomised, multicentre, open-label, phase 3b, non-inferiority study. Lancet HIV. 2021 Nov;8(11):e679-e689.
- 28) Overton ET et al. Long-Acting Cabotegravir and Rilpivirine Dosed Every 2 Months in Adults With Human Immunodeficiency Virus 1 Type 1 Infection: 152-Week Results From ATLAS-2M, a Randomized, Open-Label, Phase 3b, Noninferiority Study. Clin Infect Dis. 2023 May 3;76(9):1646-1654.
- 29) 대한감염학회(), 대한에이즈학회(), 대한항균요법학회()
- 30)
- 31) 동 재정소요금액은 요양급여비용의 총액임(보험자 및 환자 부담금의 합)
- 32) 제약사 제출 예상 사용량

	1차년도	2차년도	3차년도
보카브리아주(병)			
레감비스주사(병)			
보카브리아정(정)			
- 33) 절대재정 소요금액 = 제약사 제출 예상 사용량 × 신청약가
- 34) 재정증감액은 신청품 및 대체약제의 유지용량 소요비용 기준으로 산출함.
(산출식 = (신청약가-대체약제의 가중평균가) × 제약사 제출 예상 사용량)